

RECURSO CÍVEL Nº 5063070-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRENTE: BRENO CARVALHO AGUIAR (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE - MONITOR E SENSORES FREESTYLE LIBRE. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. PARECER DO NAT-JUS CONSIGNA QUE INSUMO NÃO É ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DA DOENÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5063070-91.2024.4.02.5101

510015445057 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063070-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRENTE: BRENO CARVALHO AGUIAR (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido que versa sobre o fornecimento, pelo Poder Público, de sistema de monitorização contínua de glicose - monitor e sensores (FreeStyle® Libre) para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"BRENO CARVALHO AGUIAR , menor impúbere, assistido por sua mãe, propõe ação em face da UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO postulando em tutela de urgência o fornecimento do insumo Sensor de Freestyle Libre e Monitor Freestyla Libre. Requer gratuidade de Justiça e prioridade de tramitação.

Como causa de pedir, afirma que sofre de diabetes melitus tipo I, com quadro de labilidade glicêmica frequente, risco de hipoglicemia e sequelas neurológicas. Que necessita do sensor capilar que informa a glicemia de forma contínua e mostra tendência de queda, possibilitando a toma da providências antes que ocorra a hipoglicemia. Que o custo total dos insumos é de R\$ 8.399,63 e não possui condições para aquisição.

Inicial e documentos no ev. 1, incluindo: a) nota técnica da CRLS; b) laudo médico emitido pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - UFRJ (fls. 22, anexo 2, ev. 1).

Gratuidade e prioridade deferidas no ev. 4.

Parecer NATJUS no ev. 7.

Decisão no ev. 9 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do Estado do Rio de Janeiro no ev. 21 postulando pela improcedência eis que o SUS oferece alternativas para tratamento da diabetes (L. 11.347/2006 e Portaria 2.583/2007) incluindo insulina, metformina, tirars reagentes e lancetas para punção digital.

Conestação da União Federal nos evs.23 e 24 suscitando preliminar de ausência de interesse processul eis que não haveria prova do prévio requerimento administrativo. No mérito, postula pela improcedência eis que o insumo não é padronizado no SUS. Trata-se de um dispositivo d monitorização contínua da glicose que oferece maior comodidade. Entretanto, não há evidência científica demonstradno que seja mais efetivo que o glicosímetro capilar. Na hipótese de procedência, requer o direcionamento do cumprimento da ordem ao Estado do Rio de Janeiro conforme Lei Estadual n. 4.119/2003.

Contestação do Município no ev. 26 postulando pela improcedência sob o argumento de que se trata de insumo não padronizado, cujo fornecimento violaria o art. 19-M da L. 8.080/90.

Em provas, nada mais foi requerido.

Relatados, decido.

De início, rejeito a preliminar de falta de interesse administrativo eis que a inicial traz documentação da Câmara de Resolução de Litígios da Saúde, na qual as esferas administrativas se fazem presentes e onde o pleito foi apresentado e rejeitado.

No mérito, a improcedência é de rigor.

A respeito da obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados o Eg. STJ fixou a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
- ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
- iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Raciocínio semelhante deve ser adotado com relação a insumos.

Conquanto o dispositivo pretendido possa trazer conforto ao diabético, a inicial não traz qualquer evidência científica de que ele seja mais eficaz do que o glicosímetro capilar fornecido pelo SUS.

Não restou comprovada, portanto, a imprescindibilidade para o tratamento do paciente, sendo certo que o SUS assegura política eficaz para enfrentamento do diabetes.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Transitada em julgado, dê-se baixa e archive-se.

P. I. (ma)"

Recorre a parte autora alegando, em síntese, que o tratamento convencional do SUS não se mostra eficaz para o seu quadro clínico, o que justifica a indicação dos insumos pleiteados nesta demanda. Pede a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença não merece reforma.

De acordo com o parecer técnico emitido pelo NATJus (evento 7, PARECER1), acolhido pelo Juízo de primeiro grau:

- a) o automonitoramento do controle glicêmico pode ser realizado através da medida da glicose no sangue capilar (teste padronizado pelo SUS) ou pela monitorização contínua da glicose (MGC);
- b) o monitoramento da Glicemia Capilar (GC) continua recomendado para a tomada de decisões no manejo de hiper ou hipoglicemia, mesmo em pacientes que utilizam monitoramento contínuo;
- c) o SMCG representa um importante avanço, mas ainda é uma tecnologia em evolução que apresenta diversas limitações;
- d) o sistema de monitorização contínua da glicose apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, não é imprescindível; e
- e) o sensor e o leitor não estão padronizados para dispensação pelo SUS, no âmbito do município e do Estado do Rio de Janeiro, bem como não foram avaliados pela CONITEC, até o presente momento.

Nesse ponto, confira-se:

Diante o exposto, informa-se que o sistema de monitorização contínua de glicose – leitor e sensores apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

No que tange à disponibilização, ressalta-se que o sistema de monitorização contínua de glicose – leitor e sensores não está padronizado, no âmbito do SUS, em nenhuma lista para dispensação no município e no Estado do Rio de Janeiro. Assim, não há atribuição exclusiva do município ou do Estado do Rio de Janeiro quanto ao seu fornecimento.

Considerando o exposto, elucida-se que o teste de referência preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) está coberto pelo SUS para o quadro clínico do Autor e que o equipamento glicosímetro capilar e os insumos tiras reagentes e lancetas estão padronizados para distribuição gratuita, no âmbito do SUS, objetivando o controle glicêmico dos pacientes dependentes de insulina.

Desse modo, considerando as especificidades do caso concreto, a improcedência se impõe, haja vista que não comprovada a imprescindibilidade clínica do insumo pleiteado. A circunstância de o tratamento ter sido prescrito pela médica assistente do autor em nada altera essa premissa.

Portanto, considero não preenchidos os requisitos elencados no REsp nº 1.657.156/RJ, julgado em sede de recurso repetitivo, e no Enunciado nº 14, da III Jornada de Saúde do CNJ. Consequentemente, a sentença de improcedência do pedido, porquanto acertada, deve ser mantida por esta instância revisora.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condene o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.